

Cuestionario de Decisiones de Negocio

Proyecto: Portal de Salud Ocupacional

Organización: ONEST Logistics

Área: Salud Ocupacional

Tipo de documento: Definición funcional y decisiones de negocio

Fecha: 20 de agosto de 2026

Estado: Propuesta para validación

1. Objetivo

El presente documento establece las decisiones funcionales propuestas para resolver los principales bloqueadores identificados durante el desarrollo del **Portal de Salud Ocupacional**.

Las definiciones buscan garantizar:

- Estandarización de información.
- Trazabilidad.
- Confidencialidad de información médica.
- Correcta explotación de datos.
- Generación de indicadores.
- Flexibilidad operativa.
- Control de accesos.
- Auditoría.
- Escalabilidad de la plataforma.

Nota: Las reglas estrictamente clínicas deberán ser revisadas y autorizadas por el Médico Jefe y/o la Gerencia de Salud Ocupacional antes de pasar a producción.

2. Causa de consulta médica

Situación

Actualmente la causa de consulta puede capturarse mediante texto libre. Esto puede generar diferentes formas de registrar una misma causa y dificultar posteriormente la generación de indicadores.

Decisión propuesta

Implementar un modelo:

Catálogo normalizado + opción "Otro" + descripción libre.

Catálogo inicial sugerido

- Enfermedad general.
- Dolor de cabeza.
- Problema gastrointestinal.
- Problema respiratorio.
- Dolor muscular.
- Dolor de espalda.
- Lesión musculoesquelética.
- Caída.
- Golpe / contusión.
- Herida / cortadura.
- Quemadura.
- Problema ocular.
- Reacción alérgica.
- Mareo.
- Presión arterial.
- Accidente de trabajo.
- Accidente en trayecto.
- Accidente no laboral.
- Seguimiento médico.
- Examen médico.
- Maternidad / embarazo.
- Curación.
- Valoración preventiva.
- Otro.

Cuando se seleccione **Otro**, deberá solicitarse una descripción.

Regla funcional

El catálogo deberá ser administrable para permitir altas, modificaciones, activación/desactivación, consulta histórica y control de duplicados.

Decisión

*Se implementará un catálogo normalizado de causas de consulta con opción **"Otro" y descripción libre**.*

Impacto

- Top de causas de consulta.
- Morbilidad por predio.
- Morbilidad por cuenta.

- Tendencias mensuales.
- Comparativos.
- Recurrencias.
- Dashboard ejecutivo.

Estado: Pendiente de validación médica.

3. Catálogo de diagnósticos

Decisión propuesta

Utilizar obligatoriamente el catálogo **ICD/CIE** disponible en el sistema para registrar el diagnóstico oficial. El texto libre deberá utilizarse únicamente para complementar la información clínica.

Modelo

Diagnóstico

-
- Código ICD/CIE
- Descripción oficial
- Observaciones clínicas
- Diagnósticos secundarios

Decisión

El diagnóstico principal deberá seleccionarse obligatoriamente del catálogo ICD/CIE. El texto libre funcionará únicamente como información clínica complementaria.

Estado: Pendiente de validación del Médico Jefe.

4. Catálogo de restricciones médicas

Decisión propuesta

Crear un catálogo administrable de restricciones médicas.

Código	Restricción
RES-01	No cargar peso
RES-02	Límite de carga
RES-03	No realizar trabajo en alturas
RES-04	No operar maquinaria
RES-05	No conducir vehículos
RES-06	Evitar movimientos repetitivos
RES-07	Evitar exposición a ruido
RES-08	Evitar exposición a sustancias

Código	Restricción
RES-09	Evitar temperaturas extremas
RES-10	Evitar esfuerzo físico intenso
RES-11	Trabajo administrativo
RES-12	Requiere pausas periódicas
RES-13	Restricción de horario
RES-14	Restricción temporal
RES-15	Uso obligatorio de equipo específico
RES-16	Otra restricción

Cada restricción podrá incluir tipo, descripción, valor límite, unidad, fecha de inicio, fecha de fin, fecha de revaloración, temporalidad, observaciones, médico responsable y estatus.

Estado: Pendiente de validación del Médico Jefe.

5. Protocolo de antidoping

Decisión propuesta

El antidoping deberá manejarse mediante un workflow configurable y auditable.

```

Solicitud
↓
Aplicación de prueba
↓
Captura de resultado
↓
Validación
↓
Seguimiento
↓
Cierre

```

El sistema deberá registrar persona, fecha, predio, motivo, tipo de prueba, responsable, resultado, evidencia autorizada, validación, observaciones, estatus y bitácora.

Las reglas sobre población aplicable, criterios de aplicación, confirmación de resultados y actuaciones posteriores deberán ser autorizadas formalmente por las áreas responsables antes de automatizarse.

Estado: Requiere definición de negocio/clínica.

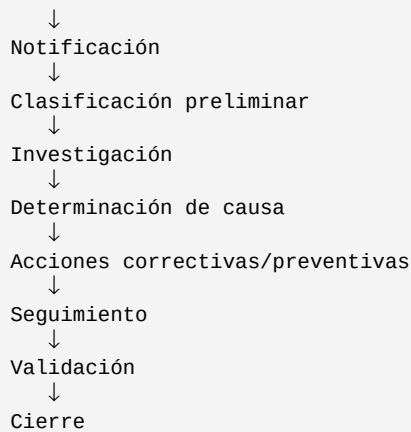
6. Investigación de accidentes

Flujo propuesto

```

Accidente
↓
Registro inicial

```



El expediente deberá incluir folio, empleado, cuenta, predio, fecha y hora, lugar, descripción, atención inicial, evidencias, responsable, clasificación, causa, acciones, responsables, fechas compromiso, seguimiento, cierre y auditoría.

Estado: Requiere validación del proceso.

7. Módulo de maternidad

Decisión propuesta

Evolucionar el registro actual hacia un módulo de seguimiento de Salud Ocupacional, sin convertirlo innecesariamente en un expediente obstétrico completo.

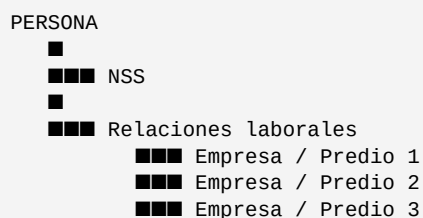
Podrá contemplar fecha de registro, semanas de gestación, fecha probable de parto, restricciones laborales, próxima revisión, observaciones, estatus, incapacidad y reincorporación cuando corresponda.

Estado: Pendiente de validación del Médico Jefe / Gerencia de Salud Ocupacional.

8. NSS y empleados multipredio

Decisión propuesta

El NSS deberá asociarse a la persona y no utilizarse como identificador único de una asignación a un predio.



Una persona podrá mantener diferentes asignaciones de empresa, cuenta, predio y puesto sin duplicar su expediente.

Estado: Pendiente de validación de RRHH.

9. Matriz de permisos y confidencialidad

Decisión propuesta

Implementar **RBAC + alcance organizacional**.

ROL
+
EMPRESA
+
CUENTA
+
PREDIO
+
TIPO DE INFORMACIÓN

Los datos clínicos deberán contar con permisos específicos independientes de los permisos técnicos o administrativos de la plataforma.

Un administrador de TI no deberá obtener acceso automático al contenido clínico únicamente por administrar el sistema.

Estado: Requiere aprobación formal.

10. Seguridad y auditoría

El portal deberá considerar como mínimo:

- Autenticación individual.
- Principio de mínimo privilegio.
- Segregación de funciones.
- Bitácora de auditoría.
- Registro de accesos a expedientes.
- Registro de modificaciones.
- Fecha, hora y usuario de cada cambio.
- Protección de información sensible.
- Control de sesiones.
- Control de exportaciones y descargas.
- Respallos.
- Gestión de bajas.
- Revisión periódica de permisos.

11. Priorización

P0 — Seguridad y arquitectura

1. Matriz de roles y permisos.
2. Modelo persona–empresa–cuenta–predio.
3. Auditoría y trazabilidad.

P1 — Normalización clínica

4. Catálogo ICD/CIE.
5. Catálogo de causas.
6. Restricciones médicas.

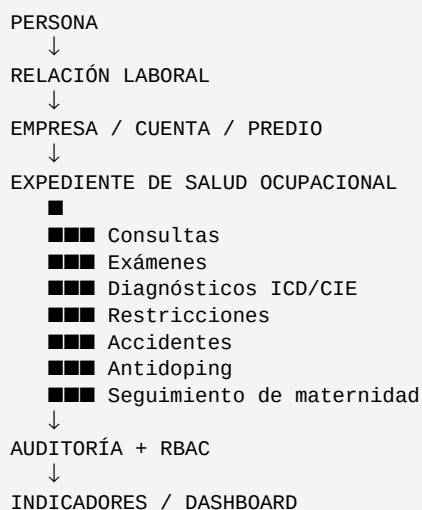
P2 — Procesos

7. Accidentes.
8. Antidoping.
9. Maternidad.

P3 — Inteligencia y reportería

- Morbilidad.
- Top de diagnósticos.
- Top de causas.
- Tendencias.
- Comparativos por predio.
- Accidentabilidad.
- Exámenes médicos.
- Restricciones.
- Indicadores autorizados.
- Seguimiento ocupacional.

12. Arquitectura funcional objetivo



13. Conclusión

Las decisiones identificadas impactan directamente el modelo de datos, seguridad, confidencialidad, workflows y reportería del Portal de Salud Ocupacional.

La recomendación es evolucionar el portal de una herramienta de captura hacia una **plataforma integral de gestión de Salud Ocupacional**, manteniendo separados los datos clínicos, las relaciones laborales, los permisos y la información destinada a análisis.

Las definiciones clínicas deberán contar con la aprobación formal de las áreas médicas correspondientes antes de su liberación a producción.